一页流程｜儿童斜视围手术期管理

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2025

1 术前评估与感染筛查

严重眼表 / 可疑眶感染？是 → 治愈后择期；否 → 明确指征、全身 / 视功能评估。

2025 刊 p501 / PDF2

2 核对与麻醉方案

眼别 / 肌肉标记及三方核对；高危眼科 + 麻醉个体化，儿童通常全麻。

2025 刊 p501 / PDF2

3 术中反射分级

心率较基线降幅 <20% 观察； 20%~50% 按血压 / 心率稳定分支； >50% 立即移钩暂停。

2025 刊 p502 / PDF3

4 重度不恢复或组织损伤

反射按原文局麻 / 阿托品升级，由麻醉处理；穿透 / 肌断裂 / 丢失 → 立即专科处理。

2025 刊 p502 / PDF3

5 术后症状分支

嗜睡 / 食欲差 + 眼红肿痛 → 排眼内炎；异常眼位 / 运动受限 / 扫视慢 → 排肌滑脱；不当作普通术后反应。

2025 刊 p503–504 / PDF4–5

6 护理用药及复查

不双眼包眼； 1 周首测用药眼压； 1 天、 1 周、第 1 、 3 、 6 个月后每半年；过 / 欠矫按原文独立分支。

2025 刊 p502–503 / PDF3–4

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。